



RUMAH SAKIT
PRIMA HUSADA

**PROGRAM KERJA PELAYANAN GERIATRI
RS PRIMA HUSADA MALANG
TAHUN 2026**

Jl. Banjararum Selatan No. 3-7 Mondoroko - Singosari, Malang

Telp. 0341-458679, 458916, Fax. 441874

Email : sekretariat@malang.rs-primahusada.com

www.rs-primahusada.com



PROGRAM KERJA PELAYANAN GERIATRI RS PRIMA HUSADA

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Meningkatnya jumlah lanjut usia menyebabkan meningkatnya masalah kesehatan akibat penyakit kronis, multipatologi, gangguan fungsi fisik, psikologis, sosial, dan lingkungan. Sesuai Permenkes Nomor 79 Tahun 2014, pelayanan geriatri di rumah sakit dilaksanakan secara terpadu dengan pendekatan multidisiplin dan interdisiplin guna meningkatkan kualitas hidup pasien lanjut usia.

Peningkatan angka harapan hidup di Indonesia berdampak pada meningkatnya jumlah populasi lanjut usia (lansia). Kelompok lansia memiliki karakteristik khusus, antara lain adanya penyakit kronis multipel, penurunan fungsi organ, gangguan mobilitas, gangguan kognitif, serta ketergantungan dalam aktivitas sehari-hari. Kondisi tersebut memerlukan pendekatan pelayanan kesehatan yang komprehensif, terpadu, dan berkesinambungan.

Pelayanan geriatri di rumah sakit tidak hanya berfokus pada pengobatan penyakit, tetapi juga pada upaya promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan paliatif secara multidisiplin. Pendekatan ini dikenal dengan pelayanan geriatri komprehensif (Comprehensive Geriatric Assessment/CGA), yang melibatkan dokter, perawat, farmasi, ahli gizi, fisioterapis, dan tenaga kesehatan lainnya.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Geriatri di Rumah Sakit, rumah sakit wajib menyelenggarakan pelayanan geriatri sesuai dengan klasifikasi dan tingkat kemampuannya. Selain itu, dalam Standar Nasional Akreditasi Rumah Sakit (SNARS) yang ditetapkan oleh Komisi Akreditasi Rumah Sakit, pelayanan kepada populasi khusus termasuk lansia menjadi bagian dari standar pelayanan berfokus pada pasien serta keselamatan pasien.

Pelayanan geriatri yang tidak terkoordinasi dengan baik berisiko menimbulkan perpanjangan lama rawat, peningkatan kejadian jatuh, polifarmasi, interaksi obat yang merugikan, malnutrisi, dekubitus, hingga peningkatan angka rehospitalisasi. Oleh karena itu, diperlukan tim pelayanan geriatri yang terstruktur dengan program kerja yang jelas, terukur, dan terdokumentasi.

Program kerja Pelayanan Geriatri disusun sebagai pedoman dalam pelaksanaan pelayanan yang terintegrasi, mulai dari skrining pasien geriatri, asesmen komprehensif, perencanaan perawatan terpadu, monitoring evaluasi, hingga perencanaan pemulangan pasien (discharge planning). Program ini juga mendukung pemenuhan indikator mutu dan keselamatan pasien sesuai standar akreditasi.

Dengan adanya Program Kerja Tim Pelayanan Geriatri, diharapkan pelayanan terhadap pasien lansia di rumah sakit dapat berjalan efektif, efisien, bermutu, serta berorientasi pada peningkatan kualitas hidup pasien dan keluarganya.



1.2 Dasar Hukum

1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Geriatri di Rumah Sakit;
3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien;
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pemeliharaan Alat Kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
5. Kepdirjen Nomor HK.02.02.D.43961.2024 tentang Pedoman Survei Akreditasi Rumah Sakit;
6. Kepdirjen Nomor 43961.2024 tentang Revisi 02 Pedoman Survei Akreditasi Rumah Sakit 7 Agustus 2024;
7. Keputusan Direktur Perseroan Terbatas Disa Prima Medika Nomor 1042.92/DPMI-KEP/DIR/IX/2025 tentang Pengangkatan PLT Direktur Rumah Sakit Prima Husada Malang.

1.3 Maksud Dan Tujuan

1. Maksud
Maksud penyusunan Program Kerja Tim Pelayanan Geriatri adalah sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan bagi pasien lanjut usia (lansia) secara komprehensif, terintegrasi, multidisiplin, dan berkesinambungan, guna memenuhi standar mutu dan keselamatan pasien sesuai ketentuan akreditasi rumah sakit yang ditetapkan oleh Komisi Akreditasi Rumah Sakit serta regulasi Kementerian Kesehatan Republik Indonesia di Indonesia.
2. Tujuan Umum
Menyelenggarakan pelayanan geriatri yang komprehensif, terpadu, dan berkesinambungan untuk meningkatkan kualitas hidup pasien lanjut usia sesuai standar akreditasi rumah sakit.
3. Tujuan Khusus
 - a. Memberikan pelayanan geriatri secara multidisiplin.
 - b. Mencegah terjadinya komplikasi pada pasien geriatri.
 - c. Meningkatkan status fungsional dan kemandirian pasien.
 - d. Menurunkan angka rehospitalisasi.
 - e. Meningkatkan keselamatan pasien dan kepuasan pasien.
 - f. Mengoptimalkan peran keluarga dalam perawatan pasien geriatri.



BAB II

GAMBARAN UMUM

2.1 VISI

“Menjadi rumah sakit berkualitas prima pilihan seluruh lapisan masyarakat”

2.2 MISI

8. Memberikan pelayanan kesehatan dengan aman, tepat, cepat dan akurat.
9. Mengutamakan kepuasan dan keselamatan pasien.
10. Meningkatkan mutu pelayanan yang berkelanjutan

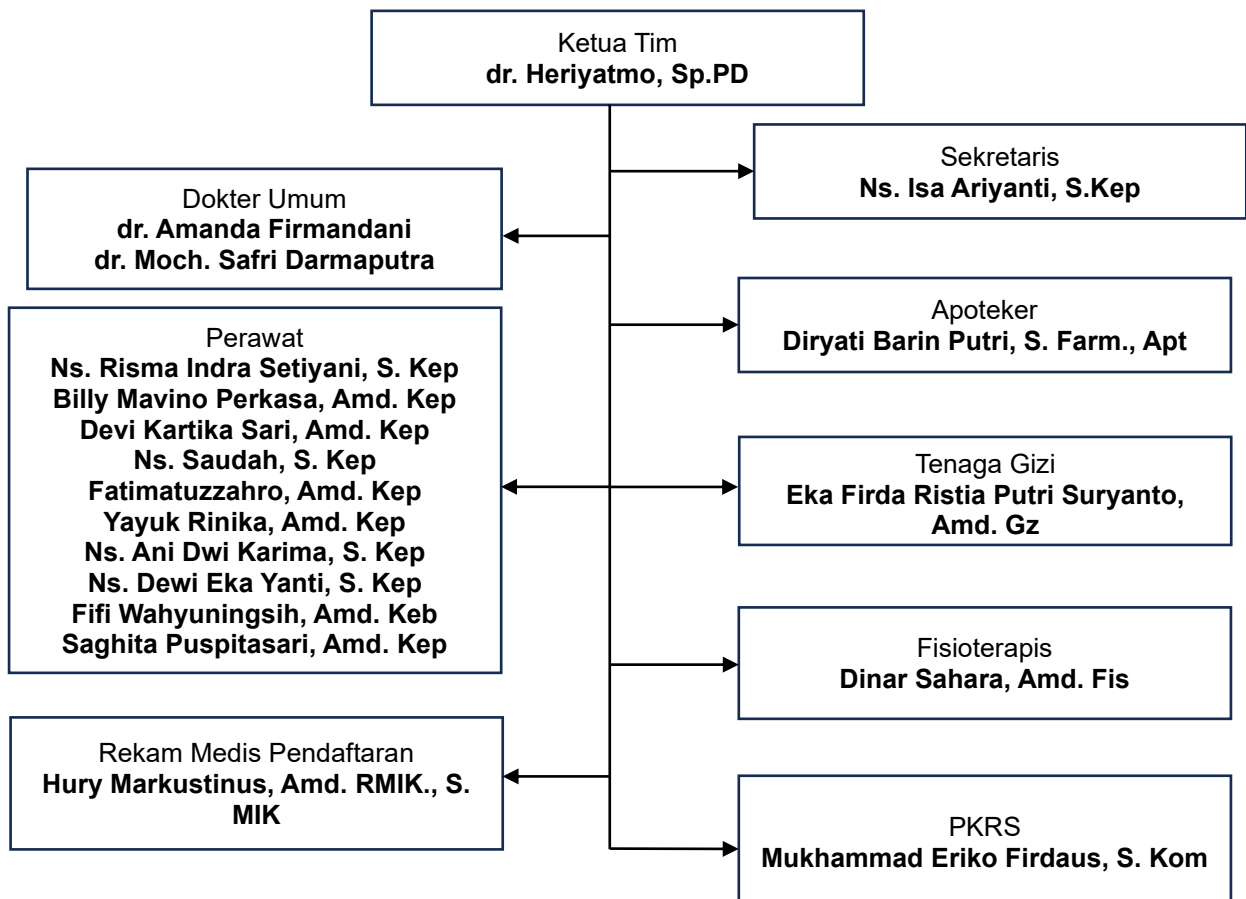
2.3 MOTTO

“Sahabat Menuju Sehat”

2.4 (7) NILAI BUDI UTAMA

1. Jujur
2. Tanggung jawab
3. Visioner
4. Disiplin
5. Kerjasama
6. Adil
7. Peduli

2.5 SOTK





BAB III

KEGIATAN DAN RINCIAN KEGIATAN

3.1 Kegiatan Pokok Dan Rincian Kegiatan

Tabel 2.2.1 Kegiatan Pokok

No	Kegiatan Pokok	Rincian Kegiatan
1	Pelayanan rawat jalan geriatri	a Identifikasi pasien geriatri b Skrining awal pasien geriatri c Pemeriksaan dan konsultasi dokter d Skrining risiko jatuh
2	Pelayanan rawat inap geriatri	a Identifikasi pasien geriatri b Penerimaan pasien rawat inap geriatri c Pelayanan medis pasien geriatri d Pelayanan medis pasien geriatri
3	Pelayanan home care/home visit	a Penetapan pasien home care oleh Tim Terpadu Geriatri b Persiapan pelayanan home visit
4	Edukasi pasien dan keluarga	a Edukasi nutrisi lansia b Edukasi pencegahan risiko jatuh c Pencegahan dekubitus dan imobilisasi
5	Pelayanan rehabilitasi medik	a Identifikasi kebutuhan rehabilitasi b Konsultasi dokter spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi
6	Pelayanan gizi klinik	a Pengkajian gizi komprehensif b Penyusunan rencana intervensi gizi c Edukasi gizi kepada pasien dan keluarga
7	Skrining risiko jatuh	a Skrining awal risiko jatuh b Pemasangan penanda risiko jatuh

3.2 Sasaran

Tabel 3.3.1 Sasaran

NO	RINCIAN KEGIATAN	TUJUAN	SASARAN KEGIATAN	JENIS	TARGET / STANDARD	INDIKATOR KEBERHASILAN	KET
1	Pelayanan rawat jalan geriatri						
	a. Identifikasi pasien geriatri	Mencegah kesalahan pasien saat pemberian pelayanan medis	Seluruh pasien geriatri rawat jalan	Pelayanan dan keselamatan pasien	100% identifikasi dilakukan sebelum pemeriksaan	Persentase kepatuhan identifikasi sebelum pemeriksaan dokter $\geq 100\%$	
	b. Skrining awal pasien geriatri	Mengidentifikasi pasien yang memerlukan pelayanan geriatri sejak awal kunjungan	Seluruh pasien usia ≥ 60 tahun di rawat jalan	Pelayanan geriatri	100% pasien usia ≥ 60 tahun dilakukan skrining awal	Persentase pasien geriatri yang diskriming awal $\geq 95\%$	
	c. Pemeriksaan dan konsultasi dokter	Mengidentifikasi keluhan utama, riwayat penyakit, riwayat pengobatan, dan kondisi sosial pasien	Seluruh pasien geriatri rawat jalan	Pelayanan medis	100% pasien geriatri mendapatkan anamnesis sesuai standar	Persentase pasien geriatri yang mendapatkan anamnesis lengkap $\geq 95\%$	
	d. Skrining risiko jatuh	Mengidentifikasi pasien yang berisiko jatuh sejak awal pelayanan	Seluruh pasien geriatri rawat jalan (≥ 60 tahun)	Skrining keselamatan pasien	100% pasien geriatri dilakukan skrining risiko jatuh	Persentase pasien geriatri yang diskriming risiko jatuh $\geq 95\%$	
2	Pelayanan rawat inap geriatri						
	a. Identifikasi pasien geriatri	Memastikan pasien yang masuk ruang perawatan teridentifikasi dengan benar	Seluruh pasien geriatri rawat inap	Keselamatan pasien	100% pasien diverifikasi menggunakan minimal 2 identitas	Persentase pasien yang terverifikasi sesuai standar $\geq 95\%$	



	b. Penerimaan pasien rawat inap geriatri	Memastikan data pasien akurat dan mencegah kesalahan identifikasi	Seluruh pasien geriatri yang akan dirawat inap	Administrasi dan keselamatan pasien	100% pasien terverifikasi menggunakan minimal 2 identitas	Persentase pasien yang terverifikasi sesuai standar $\geq 95\%$	
	c. Pelayanan medis pasien geriatri	Menetapkan diagnosis, kondisi klinis, dan rencana tata laksana sejak awal perawatan	Seluruh pasien geriatri rawat inap	Pelayanan medis	100% pasien mendapat visite awal dalam ≤ 24 jam	Persentase pasien yang mendapat visite awal tepat waktu $\geq 95\%$	
3	Pelayanan home care/ home visit						
	a. Penetapan pasien home care oleh Tim Terpadu Geriatri	Menentukan pasien yang membutuhkan pelayanan lanjutan di rumah	Pasien geriatri rawat inap dan rawat jalan	Skrining dan asesmen	100% pasien yang memenuhi kriteria teridentifikasi	Persentase pasien yang teridentifikasi sesuai kriteria $\geq 95\%$	
	b. Persiapan pelayanan home visit	Memastikan pasien memenuhi kriteria pelayanan home care	Seluruh pasien yang akan mendapatkan home care	Verifikasi administrasi dan klinis	100% pasien memiliki rekomendasi/penetapan home care	Persentase pasien dengan penetapan home care lengkap $\geq 95\%$	
4	Edukasi pasien dan keluarga						
	a Edukasi nutrisi lansia	Mengidentifikasi risiko malnutrisi sebagai dasar edukasi nutrisi	Pasien geriatri rawat inap, rawat jalan, dan home care	Asesmen gizi	100% pasien geriatri diskriminasi status gizi	Persentase pasien yang diskriminasi gizi $\geq 95\%$	
	a Edukasi pencegahan risiko jatuh	Mengidentifikasi pasien berisiko jatuh sebagai dasar edukasi	Seluruh pasien geriatri rawat inap, rawat jalan, home care	Asesmen keselamatan pasien	100% pasien geriatri diskriminasi risiko jatuh	Persentase skrining risiko jatuh $\geq 95\%$	



	b Pencegahan dekubitus dan imobilisasi	Mengidentifikasi pasien berisiko luka tekan sejak awal perawatan	Seluruh pasien geriatri rawat inap, rawat jalan tertentu, home care	Asesmen risiko	100% pasien geriatri diskriming risiko dekubitus	Persentase skrining risiko dekubitus $\geq 95\%$	
5	Pelayanan rehabilitasi medik						
	a Identifikasi kebutuhan rehabilitasi	Mengidentifikasi pasien yang membutuhkan layanan rehabilitasi sejak awal pelayanan	Seluruh pasien geriatri rawat inap, rawat jalan, dan home care	Skrining awal rehabilitasi	100% pasien geriatri diskriming kebutuhan rehabilitasi	Persentase skrining kebutuhan rehabilitasi $\geq 95\%$	
	b Konsultasi dokter spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi	Menentukan rencana terapi sesuai kondisi pasien	Pasien geriatri rawat inap, rawat jalan, dan home care	Kolaborasi multidisiplin	100% pasien dengan indikasi dilakukan konsultasi KFR	Persentase asesmen KFR lengkap $\geq 95\%$	
6	Pelayanan gizi klinik						
	a Pengkajian gizi komprehensif	Mengidentifikasi secara dini pasien geriatri yang berisiko malnutrisi	Seluruh pasien usia ≥ 60 tahun yang dirawat	Skrining gizi awal	100% pasien geriatri dilakukan skrining gizi dalam 24 jam pertama masuk rumah sakit	Persentase pasien geriatri yang diskriming gizi dalam 24 jam $\geq 95\%$	
	b Penyusunan rencana intervensi gizi	Menetapkan terapi gizi yang tepat, aman, dan sesuai kondisi pasien geriatri	Pasien geriatri yang telah selesai dilakukan pengkajian dan diagnosis gizi	Perencanaan asuhan gizi	100% pasien geriatri dengan diagnosis gizi memiliki rencana intervensi gizi individual	$\geq 90\%$ pasien memiliki rencana intervensi gizi terdokumentasi	
	c Edukasi gizi kepada pasien dan keluarga	Menentukan materi edukasi sesuai kondisi klinis, status gizi,	Pasien geriatri dan keluarga/pengasuh	Asesmen kebutuhan edukasi	100% pasien yang memerlukan	$\geq 90\%$ formulir edukasi memuat hasil	



		tingkat pemahaman, dan kemampuan pasien			edukasi dilakukan identifikasi kebutuhan edukasi	asesmen kebutuhan edukasi	
7	Skrining resiko jatuh						
	a Skrining awal risiko jatuh	Mengidentifikasi pasien geriatri yang berisiko jatuh sejak awal pelayanan	Seluruh pasien geriatri (≥ 60 tahun) yang masuk rawat inap, IGD, atau rawat jalan sesuai kebijakan RS	Skrining keselamatan pasien	100% pasien geriatri dilakukan skrining risiko jatuh pada kontak pertama pelayanan	Persentase pasien geriatri yang diskriminasi risiko jatuh $\geq 95\%$	
	b Pemasangan penanda risiko jatuh	Mengidentifikasi secara visual pasien yang berisiko jatuh sehingga seluruh petugas dapat melakukan tindakan pencegahan yang sesuai	Pasien geriatri dengan hasil skrining risiko jatuh sedang dan tinggi	Implementasi keselamatan pasien	100% pasien risiko jatuh sedang dan tinggi dipasang penanda risiko jatuh sesuai kebijakan RS	Persentase pasien risiko jatuh yang terpasang penanda $\geq 95\%$	

3.3 CARA MELAKSANAKAN KEGIATAN

Tabel 3.3.1 cara melaksanakan kegiatan

NO	RINCIAN KEGIATAN	CARA MELAKSANAKAN KEGIATAN	METODE	MEDIA	JADWAL	BUKTI PELAKSANAAN	KET
1	Pelayanan rawat jalan geriatri						
	a Identifikasi pasien geriatri	Petugas pendaftaran melakukan verifikasi umur pasien berdasarkan identitas resmi dan menandai pasien	Verifikasi administrasi dan skrining awal	KTP, kartu identitas, SIMRS, formulir pendaftaran	Setiap pasien datang ke rawat jalan	Formulir pendaftaran, data SIMRS, daftar kunjungan pasien geriatri	



		usia ≥60 tahun sebagai pasien geriatri dalam sistem pelayanan					
	b	Skrining awal pasien geriatri	Petugas melakukan identifikasi pasien usia ≥60 tahun dan mengarahkan untuk dilakukan skrining awal geriatri sesuai alur pelayanan rumah sakit	Wawancara dan observasi	Formulir skrining geriatri, rekam medis, SIMRS	Setiap kunjungan pertama pasien geriatri dan sesuai kebijakan RS	Formulir skrining yang terisi, data SIMRS
	c	Pemeriksaan dan konsultasi dokter	Dokter melakukan anamnesis, pemeriksaan fisik, dan evaluasi kondisi pasien berdasarkan hasil skrining awal geriatri	Clinical assessment (anamnesis, pemeriksaan fisik, review hasil skrining)	Rekam medis, formulir skrining geriatri, SIMRS	Setiap kunjungan pasien geriatri di poliklinik	Catatan medis dokter (SOAP), rekam medis elektronik/manual
	d	Skrining risiko jatuh	Petugas melakukan penilaian risiko jatuh pada pasien usia ≥60 tahun sebelum atau saat pelayanan di poliklinik	Observasi, wawancara, dan pengukuran sederhana	Form skrining risiko jatuh, rekam medis, SIMRS	Setiap kunjungan pasien geriatri (kunjungan pertama dan kontrol)	Form skrining risiko jatuh yang terisi lengkap
2	Pelayanan rawat inap geriatri						
	a	Identifikasi pasien geriatri	Petugas IGD/ruangan mengidentifikasi pasien usia ≥60 tahun saat admission ke ruang rawat inap	Verifikasi administratif dan klinis	KTP, rekam medis, SIMRS, formulir admission	Saat pasien pertama kali masuk rawat inap	Form admission, data SIMRS pasien geriatri
	b	Penerimaan pasien rawat inap geriatri	Petugas menerima pasien berdasarkan rujukan IGD/poliklinik/dokter spesialis dan memastikan indikasi rawat inap geriatri	Verifikasi administratif dan klinis	Surat rujukan, rekam medis, SIMRS	Saat pasien akan masuk rawat inap	Form rujukan, catatan admission di SIMRS



	c Pelayanan medis pasien geriatri	Dokter melakukan anamnesis, pemeriksaan fisik, dan evaluasi kondisi klinis pasien saat admission	Clinical assessment komprehensif	Rekam medis, form asesmen awal, hasil skrining geriatri	≤24 jam sejak pasien masuk rawat inap	Catatan medis awal (SOAP)	
3	Pelayanan home care/ home visit						
	a Penetapan pasien home care oleh Tim Terpadu Geriatri	Tim geriatri mengidentifikasi pasien rawat inap/rawat jalan yang membutuhkan perawatan lanjutan di rumah (frailty, disabilitas, penyakit kronis terminal, keterbatasan mobilitas)	Screening klinis & fungsional (CGA)	Rekam medis, hasil skrining geriatri, MNA, Barthel Index, Morse Fall Scale	Setiap hari / saat visite / saat discharge planning	Catatan identifikasi pasien dalam rekam medis	
	b Persiapan pelayanan home visit	Tim home care mengidentifikasi pasien dari rawat inap/rawat jalan yang sudah ditetapkan sebagai pasien home care	Screening berbasis keputusan tim (MDT)	Rekam medis, daftar pasien home care, SIMRS	Setelah penetapan pasien home care	Daftar pasien home care/home visit	
4	Edukasi pasien dan keluarga						
	a Edukasi nutrisi lansia	Menilai status gizi pasien melalui skrining (MNA, BB/TB, asupan makan, kondisi klinis)	Asesmen gizi awal	Form skrining gizi (MNA-SF), rekam medis	Saat admission, rawat jalan, atau home care	Hasil skrining gizi di rekam medis	
	b Edukasi pencegahan risiko jatuh	Menilai hasil skrining risiko jatuh pasien (rendah/sedang/tinggi) sebagai dasar edukasi	Asesmen risiko jatuh	Morse Fall Scale / TUG test, rekam medis	Saat admission, rawat jalan, atau home care	Hasil skrining risiko jatuh di RM	
	c Pencegahan dekubitus	Menilai pasien geriatri yang berisiko dekubitus menggunakan skala risiko dan status mobilitas	Asesmen risiko klinis	Skala Braden, rekam medis, asesmen mobilitas	Saat admission, rawat inap,	Hasil skrining risiko dekubitus di RM	



	dan imobilisasi				dan home care		
5	Pelayanan rehabilitasi medik						
	a Identifikasi kebutuhan rehabilitasi	Melakukan penilaian awal fungsi fisik, mobilitas, dan aktivitas harian pasien untuk menentukan kebutuhan rehabilitasi	Screening fungsional	Barthel Index, Katz ADL, Lawton IADL	Saat admission, rawat jalan awal, atau home care	Form skrining fungsional di rekam medis	
	b Konsultasi dokter spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi	DPJP atau tim geriatri mengajukan permintaan konsultasi rehabilitasi berdasarkan hasil asesmen fungsional	Konsultasi medis terstruktur	Form konsultasi, SIMRS, rekam medis	Saat ditemukan kebutuhan rehabilitasi	Form permintaan konsultasi Sp.KFR	
6	Pelayanan gizi klinik						
	a Pengkajian gizi komprehensif	Menentukan pasien usia ≥ 60 tahun dengan risiko malnutrisi atau penyakit kronis	Skrining awal gizi	Rekam medis, data SIMRS, hasil skrining awal	Saat admission, rawat jalan, atau home care	Daftar pasien yang akan dikaji	
	b Penyusunan rencana intervensi gizi	Menelaah data skrining, antropometri, asupan makan, dan kondisi klinis pasien	Nutrition Care Process (Assessment review)	Rekam medis, hasil MNA, data lab, form asupan makan	Setelah pengkajian gizi selesai ($\leq 24-48$ jam)	Catatan analisis gizi di RM	
	c Edukasi gizi kepada pasien dan keluarga	Mengkaji kebutuhan edukasi gizi pasien lansia (status gizi, diagnosis, kemampuan kognitif, budaya, dan dukungan keluarga)	Wawancara edukatif	Leaflet diet geriatri (diet rendah garam, diabetes, CKD, dll.)	Saat awal masuk rawat inap (≤ 24 jam setelah asesmen gizi)	Form asesmen gizi pasien geriatri	

7	Skrining resiko jatuh						
	a Skrining awal risiko jatuh	Melakukan skrining risiko jatuh segera saat pasien masuk (≤ 24 jam pertama)	Observasi langsung pasien dan Pengisian lembar skrining risiko jatuh (skala standar RS)	Formulir skrining risiko jatuh (Morse Fall Scale / instrumen RS)	Saat pasien masuk RS (skrining awal ≤ 24 jam)	Form skrining risiko jatuh yang terisi lengkap	
	b Pemasangan penanda risiko jatuh	Melakukan verifikasi hasil skrining risiko jatuh pasien (menggunakan instrumen standar seperti Morse Fall Scale atau instrumen RS)	Verifikasi data skrining risiko jatuh dan observasi pasien	Gelang identifikasi risiko jatuh (warna khusus sesuai kebijakan RS) dan Form skrining risiko jatuh	Segera setelah hasil skrining risiko jatuh ditetapkan (≤ 24 jam sejak masuk RS)	Dokumentasi hasil skrining risiko jatuh di rekam medis	

3.4 JADWAL MELAKSANAKAN KEGIATAN

Tabel 3.4.1 jadwal pelaksanaan geriatri

No	RINCIAN KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	BULAN												TEMPAT	PIC	SUMBER DANA	
			12/25	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				12
1	Pelayanan rawat jalan geriatri																	
	a. Identifikasi pasien geriatri	Seluruh pasien usia ≥60 tahun		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	IRJA	Tim geriatri	RS Prima Husada Malang
	b. Skrining awal pasien geriatri	Teridentifikasinya pasien usia ≥60 tahun yang memerlukan pelayanan geriatri berdasarkan kondisi medis, fungsional, psikologis, sosial, dan risiko jatuh sehingga pasien memperoleh		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	IRJA	Dokter DPJP, Tim Terpadu Geriatri	RS Prima Husada Malang



		pelayanan yang tepat dan komprehensif																
	c. Pemeriksaan dan konsultasi dokter	Terlaksananya pemeriksaan dan konsultasi medis secara komprehensif terhadap pasien geriatri untuk mendeteksi, menegakkan diagnosis, menentukan terapi, serta meningkatkan kualitas hidup lansia sesuai kebutuhan medis dan prinsip pelayanan geriatri terpadu		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	IRJA	Dokter Spesialis Penyakit Dalam/DPJP	RS Prima Husada Malang
	d. Skrining risiko jatuh	Seluruh pasien geriatri yang berobat di poliklinik/rawat jalan agar teridentifikasi risiko jatuh secara dini dan dilakukan intervensi yang tepat		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Ruang pemeriksaan poliklinik	Tim geriatri	RS Prima Husada Malang
2	Pelayanan rawat inap geriatri																	
	a. Identifikasi pasien geriatri	Seluruh pasien usia ≥60 tahun dengan multipatologi		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	IRNA	Dokter Penanggung Jawab Pelayanan (DPJP), Dokter Jaga	RS Prima Husada Malang
	b. Penerimaan pasien rawat inap geriatri	Terselenggaranya pengkajian awal meliputi status fisik, psikologis, fungsional, risiko jatuh, status nutrisi, dan kebutuhan khusus pasien lansia		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	IRNA	Perawat Penanggung Jawab Pasien	RS Prima Husada Malang



	c. Pelayanan medis pasien geriatri	Terlaksananya pelayanan medis yang komprehensif, holistik, dan terintegrasi bagi pasien geriatri sesuai kebutuhan klinis serta menjamin keselamatan pasien		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	IRNA	Dokter Penanggung Jawab Pelayanan (DPJP), Dokter Spesialis Penyakit Dalam	RS Prima Husada Malang
	d. Pelayanan medis pasien geriatri	Seluruh pasien geriatri yang dirawat memperoleh penilaian medis, fungsional, psikologis, sosial, dan nutrisi secara menyeluruh		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	IRNA	DPJP dan Tim Medis Geriatri	RS Prima Husada Malang
3	Pelayanan home care/ home visite																	
	a. Penetapan pasien home care oleh Tim Terpadu Geriatri	Teridentifikasinya pasien geriatri yang memenuhi kriteria pelayanan home care/home visit		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Ruang rawat inap atau poliklinik	Tim geriatri	RS Prima Husada Malang
	b. Persiapan pelayanan home visit	Tersusunnya jadwal home visit sesuai tingkat kebutuhan pasien		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	IRNA	Tim geriatri	RS Prima Husada Malang
4	Edukasi pasien dan keluarga																	
	a. Edukasi nutrisi lansia	Meningkatkan pengetahuan pasien lansia dan keluarga tentang pola makan seimbang, pencegahan malnutrisi, serta kepatuhan terhadap diet yang dianjurkan sehingga mendukung		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Rawat jalan geriatri, ruang rawat inap, ruang edukasi, dan home care	Tim geriatric (Ahli Gizi)	RS Prima Husada Malang



		peningkatan status kesehatan dan kualitas hidup lansia																
	b. Edukasi pencegahan risiko jatuh	Meningkatkan pengetahuan pasien dan keluarga mengenai faktor risiko jatuh, penggunaan alat bantu, tata cara mobilisasi yang aman		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Ruang Rawat Inap, Poliklinik dan Home Care	Tim geriatri	RS Prima Husada Malang
	a. Pencegahan dekubitus dan imobilisasi	Meningkatkan pengetahuan pasien dan keluarga mengenai faktor risiko terjadinya dekubitus dan komplikasi akibat imobilisasi		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Ruang Rawat Inap	Tim geriatri	RS Prima Husada Malang
5	Pelayanan rehabilitasi medik																	
	a Identifikasi kebutuhan rehabilitasi	Tersusunnya kebutuhan rehabilitasi pasien sesuai kondisi klinis dan tingkat kemandirian pasien		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Unit Rehabilitasi Medik, Ruang Rawat Inap	Dokter Sp.KFR, Fisioterapis	RS Prima Husada Malang
	b Konsultasi dokter spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi	Pasien yang memerlukan pelayanan rehabilitasi medik sesuai indikasi medis		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Poliklinik Rehabilitasi Medik	Dokter Sp.KFR, Fisioterapis	RS Prima Husada Malang
6	Pelayanan gizi klinik																	
	a Pengkajian gizi komprehensif	Seluruh pasien rawat inap dan rawat jalan yang hasil skrining gizinya menunjukkan risiko malnutrisi		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Ruang rawat inap, poliklinik	Nutrisi	RS Prima Husada Malang
	b Penyusunan rencana intervensi gizi	Tersedianya data status gizi, diagnosis gizi, dan kebutuhan zat gizi pasien secara lengkap dan akurat		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Ruang rawat inap, poliklinik	Nutrisi	RS Prima Husada Malang



	c Edukasi gizi kepada pasien dan keluarga	Meningkatnya pengetahuan pasien dan keluarga tentang diet yang tepat sehingga mendukung keberhasilan terapi		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Rawat inap, rawat jalan	Nutrisi	RS Prima Husada Sukorejo
7	Skrining resiko jatuh																	
	a Skrining awal risiko jatuh	Seluruh pasien rawat inap, rawat jalan, IGD, dan pasien yang akan menjalani tindakan sesuai kriteria skrining risiko jatuh		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Rawat inap, rawat jalan, IGD	Perawat Penanggung Jawab Pasien	RS Prima Husada Malang
	b Pemasangan penanda risiko jatuh	Seluruh pasien dengan risiko jatuh rendah, sedang, maupun tinggi sesuai kriteria yang ditetapkan rumah sakit memperoleh penanda risiko jatuh sebagai upaya pencegahan cedera		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Rawat inap, rawat jalan, IGD	Perawat Penanggung Jawab Pasien	RS Prima Husada Malang

3.5 KEBUTUHAN ANGGARAN

Tabel 3.5.1 Kebutuhan Anggaran

NO	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	JENIS	KEBUTUHAN SATU TAHUN	HARGA SATUAN	TOTAL ANGGARAN
1	Pelayanan rawat jalan geriatri					
	a. identifikasi pasien geriatri	Penyusunan dan penggandaan formulir skrining/identifikasi pasien geriatri	E-RM	Dokumen E-RM	Rp.0	Rp.0
	b. Skrining awal pasien geriatri	Penyediaan formulir skrining geriatri	E-RM	Dokumen E-RM	Rp.0	Rp.0
	c. Pemeriksaan dan konsultasi dokter	Pemeriksaan dan konsultasi dokter spesialis penyakit dalam	Pelayanan	Dokumen E-RM	Rp.0	Rp.0
	d. Skrining risiko jatuh	Pelaksanaan skrining risiko jatuh pada pasien rawat jalan	Pelayanan	Dokumen E-RM	Rp.0	Rp.0

2	Pelayanan rawat inap geriatri					
	a. Identifikasi pasien geriatri	Penyusunan formulir skrining pasien geriatri	Pelayanan	Dokumen E-RM	Rp.0	Rp.0
	b. Penerimaan pasien rawat inap geriatri	Pengkajian awal pasien geriatri saat masuk rawat inap	Pelayanan	Dokumen E-RM	Rp.0	Rp.0
	c. Pelayanan medis pasien geriatri	Pelaksanaan asesmen geriatri	Pelayanan	Dokumen E-RM	Rp.0	Rp.0
3	Pelayanan home care/ home visite					
	a. Penetapan pasien home care oleh Tim Terpadu Geriatri	Koordinasi antar profesi dalam penetapan pasien home care	Pelayanan	Dokumen E-RM	Rp.0	Rp.0
	b. Persiapan pelayanan home visit	Penyusunan pedoman dan SPO pelayanan home visit	Pelayanan	Dokumen E-RM	Rp.0	Rp.0
4	Edukasi pasien dan keluarga					
	a. Edukasi nutrisi lansia	Penyusunan materi edukasi nutrisi lansia Edukasi individu pasien dan keluarga di rawat jalan dan rawat inap	Leaflet	500 lembar	Rp.1500	Rp.750.000
	b. Edukasi pencegahan risiko jatuh	Pembuatan leaflet pencegahan risiko jatuh Pelaksanaan edukasi individu pasien dan keluarga	Leaflet	500 lembar	Rp.1500	Rp.750.000
	a. Pencegahan dekubitus dan imobilisasi	Edukasi pencegahan dekubitus kepada pasien dan keluarga	Leaflet	500 lembar	Rp.1000	Rp.500.000
5	Pelayanan rehabilitasi medik					
	a. Identifikasi kebutuhan rehabilitasi	Pelaksanaan asesmen kebutuhan rehabilitasi pasien geriatri	Pelayanan	Dokumen E-RM	Rp.0	Rp.0
	b. Konsultasi dokter spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi	Konsultasi pasien geriatri oleh dokter spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi	Pelayanan	Dokumen E-RM	Rp.0	Rp.0
6	Pelayanan gizi klinik					
	a. Pengkajian gizi komprehensif	Pengkajian status gizi pasien geriatri menggunakan formulir asesmen gizi	Leaflet	500 lembar	Rp.1500	Rp.750.000



		Pengkajian asupan makanan dan riwayat diet				
	b. Penyusunan rencana intervensi gizi	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan intervensi gizi	Pelayanan	Dokumen E-RM	Rp.0	Rp.0
	c. Edukasi gizi kepada pasien dan keluarga	Penyusunan materi edukasi gizi Penggandaan leaflet edukasi gizi	Leaflet	500 lembar	Rp.1000	Rp.500.000
7	Skrining resiko jatuh					
	a. Skrining awal risiko jatuh	Pengadaan gelang penanda risiko jatuh pasien risiko tinggi	Pita kuning	500 buah	Rp.5000	Rp.2.500.000
	b. Pemasangan penanda risiko jatuh	Pengadaan stiker/logo risiko jatuh untuk tempat tidur dan rekam medis	Bahan habis pakai	500 lembar	Rp.5000	Rp.2.500.000



BAB IV

MONITORING DAN EVALUASI

4.1 MONITORING

1. Tujuan
 - a. Memastikan pelaksanaan program kerja sesuai Rencana Strategis (Renstra).
 - b. Menjamin kepatuhan terhadap standar akreditasi dan regulasi Kemenkes.
 - c. Mengukur capaian indikator mutu dan keselamatan pasien.
 - d. Mengidentifikasi risiko dan hambatan.
 - e. Menyusun Rencana Tindak Lanjut (RTL) berbasis data
2. Ruang Lingkup Monitoring
 - a. Pelayanan Medis & Keperawatan
 - b. PMKP (Peningkatan Mutu & Keselamatan Pasien)
 - c. PPI (Pencegahan & Pengendalian Infeksi)
 - d. Manajemen Risiko
 - e. SDM & Kredensial
 - f. Sarana Prasarana & K3RS
 - g. ~~Manajemen Rekam Medis~~
 - h. Keuangan & Administrasi
3. Metode Monitoring
 - a. Audit Internal Berkala
 - b. Monitoring Indikator Mutu
 - c. Telaah Rekam Medis
 - d. Observasi Lapangan
 - e. Survey Kepuasan Pasien

4.2 EVALUASI

1. Tujuan
 - a. Menilai capaian indikator kinerja dan mutu.
 - b. Mengukur efektivitas program kerja unit dan manajemen.
 - c. Mengidentifikasi hambatan dan risiko.
 - d. Menyusun Rencana Tindak Lanjut (RTL).
 - e. Menjadi bukti objektif dalam survei akreditasi dan audit internal.
2. Metodologi Evaluasi
 - a. Analisis capaian indikator (triwulan & tahunan)
 - b. Audit internal & telaah dokumen
 - c. Review laporan insiden keselamatan pasien
 - d. Survey kepuasan pasien
 - e. Rapat Tinjauan Manajemen (RTM)
3. Prosedur evaluasi
 - a. Pengumpulan data
 - 1) Mengumpulkan seluruh laporan monitoring bulanan/ triwulan/ semester/ tahunan.
 - 2) Mengumpulkan indikator mutu dan keselamatan pasien yang terkait layanan keperawatan
 - 3) Mengumpulkan laporan kegiatan sub komite
 - b. Verifikasi kebenaran data
 - 1) Analisis pelaksanaan program
 - 2) Membandingkan realisasi program kerja dengan rencana tahunan
 - 3) Menilai tingkat capaian (% target tercapai)
 - 4) Menganalisis kesesuaian pelaksanaan dengan standar akreditasi dan permenkes



-
- 5) Mengidentifikasi ketidaksesuaian, kendala dan risiko
 - c. Penilaian efektifitas program
 - 1) Menilai manfaat program terhadap peningkatan mutu
 - 2) Menilai dampak terhadap keamanan pasien dan praktik profesional
 - d. Penetapan temuan evaluasi
 - Klasifikasi temuan:
 - 1) Kritis : berdampak pada keselamatan pasien/ etik/ disiplin
 - 2) Mayor : pelanggaran signifikan terhadap SPO/ standar
 - 3) Minor : ketidaksesuaian yang tidak berdampak langsung
 - e. Penyusunan rekomendasi
 - 1) Membuat rekomendasi perbaikan spesifik dan terukur
 - 2) Menyusun prioritas berdasarkan urgensi dan risiko
 - 3) Mengidentifikasi kebutuhan pelatihan, revisi SPO atau perubahan prosedur



BAB V

PENCATATAN DAN PELAPORAN

5.1 PENCATATAN

1. Semua kegiatan Geriatri dicatat sesuai jenis kegiatan dan SPO nya.
2. Laporan disusun berdasarkan laporan dari unit kerja dan setiap 3 bulan Tim Geriatri melaporkan kegiatan ke Direktur

No	Rencana Kegiatan	Tujuan	Indikator Keberhasilan	Petugas
1.	Pembuatan laporan triwulan	Pertanggung jawaban kepada Direktur	Laporan Triwulan	Ketua dibantu sekretaris
2.	Monitoring kegiatan Tim Geriatri (senam lansia, yoga lansia, kegiatan rohani, posyandu lansia dan home care)	Memantau proses kegiatan yang sedang berlangsung	Anggota Tim Geriatri dapat melakukan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab dan wewenangnya	Tim Geriatri
3.	Monitoring pelayanan geriatri (rawat jalan dan rawat inap)	Memantau proses pelayanan di unit	Anggota Tim Geriatri dapat melakukan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab dan wewenangnya	Tim Geriatri

5.2 PELAPORAN

1. Evaluasi pelaksanaan program secara menyeluruh dilakukan melalui rapat Tim Geriatri setiap 3 bulan sekali.

No	Rencana Kegiatan	Tujuan	Indikator Keberhasilan	Petugas
1.	Rapat bulanan sebagai evaluasi kegiatan	Evaluasi program bulanan Membahas masalah yang ada Mencari solusi	Program geriatri dilaksanakan Laporan bulanan tepat waktu	Ketua dibantu sekretaris Anggota Tim Geriatri
2.	Rapat koordinasi Tim Geriatri	Evaluasi terkait pelayanan dan program geriatri	Pelayanan dan program geriatri dilaksanakan Laporan bulanan tepat waktu	Ketua dibantu sekretaris Anggota Tim Geriatri



BAB VI

PENTUUP

Pelaksanaan Program Kerja Geriatri Tingkat Lengkap di Rumah Sakit Prima Husada merupakan wujud komitmen rumah sakit dalam memberikan pelayanan kesehatan yang komprehensif, terpadu, dan berkesinambungan bagi pasien lanjut usia. Program ini disusun mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Geriatri di Rumah Sakit, serta standar akreditasi nasional yang ditetapkan oleh Komisi Akreditasi Rumah Sakit (KARS).

Demikian Program Kerja Geriatri ini disusun sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan selama periode yang telah ditetapkan. Evaluasi dan perbaikan berkelanjutan akan senantiasa dilakukan untuk menjamin efektivitas dan keberlanjutan program

Malang, 01 Januari 2026

PLT Direktur RS Prima Husada Malang



dr. Resti Lestantini, M. Kes

Ketua Geriatri

dr. Heriyatmo, Sp.PD